EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 75780
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-12-14 13:07:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ERNA ROSA BAHAMONDEZ CARO			RUN	: 4.197.510-5
F.Nac	: 26-05-1937	Edad	: 86 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: OSSA 762			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 04-12-2023	Fecha Egreso	: 2023-12-14 13:07:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico parietal derecho subagudo, obs embólico (7 días de evolución previo a ingreso)
-UPP sacra
-Anemia moderada sin repercusión HDN, 2° HDA (neoplasia?)
-Hipocalcemia resuelta
-Neumonía aspirativa resuelta
-Demencia, mRS 5

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente en buenas condiciones, HDN estable con HTA moderada, RS al monitor, afebril, eupneica, mantiene reactividad, emite vocablos aislados, deglución suficiente con tos muy ocasional al ingerir liquidos finos, aunque esta en condiciones de retiro de SNG familia decide mantenerla y evaluar retiro en seguimiento en HODOM. Impresiona sin dolor y se observa tranquila. Logra bipedestación con 2 operadores.
test Weber resulto(+), se administró TXA 1g EV ayer, sin RAM. Resto exs mostraron estabilidad de anemia, PCR en descenso, fx renal N, Ca N, VHS alta (neoplasia oculta?). Se acuerda con familia no avanzar por ahora en estudio de HDA con EDA en vista de la edad y condición funcional de la paciente. Se decidirá posteriormente.
Dep(+) liquidos oscuras, diuresis(+)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy y continuar rehabilitación fonoaudiológica y kinésica por HODOM.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días
-IC HODOM para continuar rehabilitación fonoaudiológica y kinésica
-No usar aspirina o anticoagulantes
-EDA ambulatoria
-Reiniciar resto tto crónico

INDICACIONES AL ALTA

1. -Omeprazol 20 mg c/12 horas
2. -Atorvastatina 40 mg/noche

3. -Losartan 50 mg/d, si mantiene PA>140, aumentar a 50 mg c/12h

EXÁMENES Y RESULTADOS

14/12/23
-Crea 0.9 Uremia 16
-Ca 8.3 Ca corr 9.74
-FA 90 BI 0.12 BT 0.3 GOT 19 GPT 16 GGT 32
-PCR 38.8
-Leu 8000 Hb 8 Plaq 333000 Seg 80 VHS 86 Ret 3.6
-INR 1.1 TTPA 28

13/12/23
-Test Weber(+)
-LF(-)
-CD(-)

12/12/23
-Na 142 K 3.9 Cl 110
-Leu 6500 Hb 7.7 Plaq 280000 Seg 74 Linf 11 VHS 66

11/12/23
-Alb 2.2
-Crea 0.8 MDRD 68.01 Uremia 9
-Ca 6.4 Ca corr 7.84
-Na 140 K 3 Cl 108
-Leu 7000 Hb 7.6 Plaq 264000 Seg 75 VHS 55

8/12/23
-Crea 1 MDRD 52.57 Uremia 37
-PCR 49.9
-Na 138 K 3.7 Cl 113
-Leu 9300 Hb 8.1 Plaq 247000 Seg 78 VHS 32

7/12/23
-Crea 1 MDRD 52.27 Uremia 67
-PCR 40.9
-Na 134 K 4 Cl 107
-Leu 10400 Hb 7.9 Plaq 242000 Seg 86 VHS 24
-Procal 0.19
-RPR N/R

6/12/23
-Alb 2.9
-Crea 1.1 MDRD 47.09 Uremia
-Ca 7.9 Ca corr 8.78
-FA 95 BI 0.11 BD 0.19 BT 0.3 GOT 17 GPT 12 GGT 30
-ColT 129 HDL 37 LDL 55 VLDL 37 TG 185
-PCR 66.2
-Na 153 K 4.1 Cl 121
-Leu 12000 Hb 9.2 Plaq 294000 Seg 94 VHS 61
-INR 1.14 TTPA 25
-TSH 0.575 T4L 0.88 B12 7393 Vit D 4.9
-Procal 0.26

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación conservadas, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR, 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, emite lenguaje muy escaso, no sigue órdenes
-PC: CV impresiona hemianopsia izquierda, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, motilidad y sensibilidad faciales N, nistagmo(-), lengua central, resto n/e
-Motor: retira simétrico en las 4 EE, al menos M2-3 (levemente menor en ESD), RCP flexor bilateral
-Sensitivo: algesia impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO